**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**Vara Estadual da Saúde Pública**

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

**TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5004544-22.2022.8.21.1001/RS**

**REQUERENTE**: GERTA RUDOLF BRACK
**REQUERIDO**: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# SENTENÇA

**GERTA RUDOLF BRACK** ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alegando possuir diagnóstico de Doença de Alzheimer (CID G31) Hipertenção (CID I10), Ansiedade Generalizada (F41), Demência (CID 10 FO2), apresentando Surtos Psicóticos (F23.9), Insônia (G47.2) e Artrose do Joelho (M17), Fratura do Fêmur (S72) e dor crônica (R52.2) e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **1Pure Cannabidiol CBD isolado 6000mg/200mg-ml**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecido o tratamento postulado (evento 1, INIC1).

Deferida a tutela de urgência (evento 33, DESPADEC1).

Citado, o réu contestou alegando a necessidade de observância do Tema 793-STF, com a inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda (evento 48, CONT1).

Não houve réplica.

Foi determinado bloqueio de valores (evento 58, DESPADEC1), prestadas as contas (eventos 86, 98, 106 e 114), e, inexistindo oposição por parte do ente demandado (evento 117), foram as contas homologadas (evento 122, DESPADEC1).

Sobreveio decisão proferida no agravo de instrumento interposto pelo demandado, para remessa dos autos à Justiça Federal (evento 29, RELVOTO1), o que acarretou a declinação de competência para aquela Justiça (evento 122, DESPADEC1).

Na Justiça Federal, foi determinada a exclusão da União do polo passivo, por inexistência de litisconsórcio necessário, ilegitimidade passiva e inviabilidade de obrigar a parte autora a litigar contra quem não dirigiu o pleito, e resituídos os autos ao Juízo Etadual (evento 136, DESPADEC1).

Intimadas as partes quanto ao interesse na produção de outras provas (evento 140, DESPADEC1), o demandado manifestou desinteresse (evento 147, PET1) ao passo que a parte autora não se manifestou (Evento 141).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 151, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

## I. DO MÉRITO

### I.1. Direito à Saúde

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu artigo 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o artigo 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu artigo 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde -, e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu artigo 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e do Município, a ser ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o dever do Estado, lato sensu considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 23, II e 196, ambos da Constituição Federal. Neste sentido: RE nº 557.548/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 155, publicado em 05.12.2007.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. Nesse sentido a Apelação Cível Nº 70050003987, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 31/07/2012.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, visto que ao Judiciário compete fazer cumprir a ordem jurídica.

## I.2. Da necessidade do tratamento

A tutela de urgência foi deferida (evento 33, DESPADEC1), a qual abaixo colaciono e passo a ratificar:

*No presente feito, conforme o **laudo médico** juntado aos autos, de lavra da **Dra. Anelise Brack Gestaro (CRM-RS 018784) (evento 1, OUT10)**, a parte autora apresenta o diagnóstico de Doença de Alzheimer (CID G31) Hipertenção (CID I10), Ansiedade Generalizada (F41), Demência (CID 10 FO2), apresentando Surtos Psicóticos (F23.9), Insônia (G47.2) e Artrose do Joelho (M17), Fratura do Fêmur Idreito (S72) e dor crônica (R52.2), necessitando fazer uso do fármaco **1Pure Cannabidiol CBD isolado 6000mg/200mg-ml**, na dosagem de 3,5 ml, de 12 em 12 horas**.** Refere a médica assistente que a paciente foi diagnosticada há aproximadamente 10 anos, tendo utilizado diversos fármacos testados e disponíveis no Brasil, sem contudo uma melhora clínica, tendo apresentado piora progressiva de seu quadro.*

*De acordo com o laudo médico, a paciente apresenta hipotonia muscular, rigidez muscular, perda de equilíbrio resultando em muitas quedas, instabilidade ao caminhar, dificuldade com movimentos corporais, inclusive com fratura do fêmur sem quedas, dores lombares intensas e incapacitantes, e com possível agravamento por uma maior sensibilidade aos fármacos neurolépticas, resultando em um aumento de progressão da doença. Ainda, segundo a médica assistente, a paciente vem apresentando surtos psicóticos e muita ansiedade.*

*Além disso, narra que a paciente já fez uso dos seguintes fármacos: memantina, quetiapina, clonazepam, tramadol, zolpidem e melatonina; bem como que o uso destes medicamentos resultou nos seguintes efeitos colaterais: alterações do humor com picos e alternada, sonolência excessiva, insônia consecutiva, boca seca, dores musculares, náuseas, perda de peso, falta de ar, alterações gastrointestinais, anorexia, agitação, dor de cabeça, fadiga, palidez, tontura, arritmia, distúrbios visuais, falta de equilíbrio, fala arrastada, problema de memória, irritabilidade, dentre outros.*

*Por fim, de acordo com o laudo médico, a médica assistente atesta que o Canabidiol é a última possibilidade terapêutica para a melhora do quadro geral da paciente e de sua qualidade de vida. Por fim, atesta que a paciente deve iniciar o tratamento em caráter de urgência, tendo em vista a possibilidade de desenvolvimento de dano irreversível para a sua saúde geral e até mesmo risco de morte pela gravidade do caso.*

*Por sua vez, a nota técnica emitida através do Sistema e-NatJus concluiu **desfavoravelmente** à concessão do tratamento postulado pela parte autora (evento 31, NOTATEC1). Veja-se:*

***Conclusão Justificada:** Não favorável*

***Conclusão:** Trata-se de solicitação do medicamento Canabidiol para tratamento de dificuldade para deambular, sintomas psiquiátricos e distúrbio do sono em paciente com Doença de Alzheimer.*

*Esclarecemos ao Juízo que a Doença de Alzheimer é uma doença crônica, de caráter progressivo e incurável, manifestada por declínio cognitivo e distúrbios comportamentais característicos, levando à incapacitação e morte, e que cursa com a diminuição da função colinérgica central, principalmente em áreas límbicas e têmporo-parietais. A duração da doença varia de 3 a 20 anos, usualmente de 7 a 10 anos, com progressão lenta. Os pacientes são suscetíveis a lesões não intencionais e infecções. O óbito geralmente decorre de pneumonia, desnutrição, desidratação e sepse resultante de úlceras de pressão ou infecções do trato urinário.*

*O tratamento envolve estratégias farmacológicas e intervenções psicossociais para o paciente e seus familiares.*

*Inúmeras substâncias psicoativas têm sido propostas para preservar ou restabelecer a cognição, o comportamento e as habilidades funcionais do paciente, que são os Inibidores da colinesterase (rivastigmina, galantamina, donepezil) e um Antagonista dos receptores NMDA (memantina). Os Inibidores da colinesterase podem ser usados em qualquer fase da doença (grau de recomendação 1A) e não há diferença de eficácia destes medicamentos em estudos de comparação direta. A combinação de um Inibidor da colinesterase (Rivastigmina, Galantamina, Donepezil) e Memantina é considerada racional já que o mecanismo de ação é diferente, parece ser segura (grau de recomendação 2B) e é recomendada nos estágios moderado e grave da doença. O tratamento é continuado devendo ser reavaliado a cada seis meses e sujeito à suspensão a critério médico.*

*Todos estes medicamentos são disponibilidados pela rede pública como componentes especializados de assistência farmacêutica em Protocolo específico do Ministério da Saúde para tratamento da Doença de Alzheimer, os medicamentos inibidores da acetilcolinesterase são recomendados para doença em estágio leve a moderado, enquanto que a memantina para os estágios moderado a grave.*

*No que diz respeito ao canabidiol, temos a fazer as seguintes considerações.*

*Com base em dados de quatro estudos pequenos, curtos e heterogêneos controlados por placebo, não podemos ter certeza se os canabinóides têm algum efeito benéfico ou prejudicial na demência. Se houver benefícios dos canabinoides para pessoas com demência, os efeitos podem ser muito pequenos para serem clinicamente significativos. Ensaios metodologicamente robustos e com poder adequado, com acompanhamento mais longo, são necessários para avaliar adequadamente os efeitos dos canabinóides na demência.*

*Recentemente, a Resolução nº 2324/2022 do Conselho Federal de Medicina restringiu o uso de Canabidiol, autorizando sua prescrição como terapêutica médica para o tratamento de Epilepsias na infância e adolescência refratárias às terapias convencionais na Síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e no Complexo de Esclerose Tuberosa, sendo VEDADO ao médico a prescrição de Canabidiol para indicação terapêutica diversa da prevista nesta Resolução, salvo em estudos clínicos autorizados pelo Sistema CEP/CONEP.*

*Do ponto de vista neurológico, não vemos recomendação técnica.*

*No que diz respeito aos sintomas comportamentais, sugere-se parecer de médico psiquiatra.*

***Há evidências científicas?** Não*

***Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?** Não*

*Contudo, no caso concreto, **em sede de tutela de urgência**, há que se prestigiar o entendimento da médica assistente que acompanha a paciente, tendo em vista o valor em causa: vida e saúde do paciente/autor. Em instrução, caso ocorra, poderá ser melhor dirimida a questão da divergência de entendimentos (e-NatJus e médica assistente).*

*Assim, no caso em apreço, em sede **liminar**, resta suficientemente demonstrada a necessidade da prestação de saúde postulada pela parte autora, bem como evidenciados o perigo de dano.*

*Para a concessão da tutela de urgência se faz imperioso que haja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).*

*Por oportuno, colaciono a doutrina a seguir:*

*Acrescento que o denominado "requisito negativo" da tutela antecipada do par. 3º do art. 300 do Código de Processo Civil é inconstitucional, sobretudo em razão da sua inconsistência fenomenológica. Portanto, desnecessário cogitar da aplicação da teoria da irreversibilidade recíproca para deferir ou indeferir qualquer tutela de urgência antecipada.*[1]

*No caso em apreço, resta suficientemente evidenciada nos autos a necessidade de utilização da medicação pela parte autora.*

*Diante das alegações médicas, entendo que a não concessão da medicação postulada atentaria diretamente contra o direito constitucionalmente garantido à saúde, na medida em que, devido a impedimentos de ordem administrativa, a parte autora teria prejudicada de forma considerável a possibilidade de diminuição dos efeitos decorrentes de suas enfermidades.*

*Dessa forma, assegurado o direito da parte autora em ter a sua saúde resguardada, e comprovada a necessidade que possui em receber a medicação na dosagem postulada, de modo a permitir o seu tratamento, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela pretendida.*

*Diante do exposto,* ***DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA*** *para determinar ao* ***ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL*** *que disponibilize à parte autora, no prazo de* ***05 (cinco) dias****, o medicamento* ***1Pure Cannabidiol CBD isolado 6000mg/200mg-ml****, na dosagem de 3,5 ml, de 12 em 12 horas****, conforme receita e laudo médico acostados à inicial,*** *pelo tempo necessário para a realização do tratamento.*

No julgamento do **Recurso Especial nº 1.657.156 (TEMA 106),** o STJ estabeleceu que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos via SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: **1)** comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; **2)** incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e **3)** existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

No caso dos autos, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos.

O primeiro requisito resta comprovado pela documentação médica acostada aos autos (evento 1, OUT10), que refere à necessidade no uso do medicamento **1Pure Cannabidiol CBD isolado 6000mg/200mg-ml**, e que não houve benefícios com a utilização dos outros fármacos disponíveis no SUS:

RELATÓRIO MÉDICO

Paciente Gerta Rudolf Brack, 91 anos, diagnosticado há aproximadamente 10 anos com Doença de Alzheimer CID G31, hipertensa CID I10 , ansiedade generalizada F41 e a 2 anos com Demência CID 10 F02, surtos psicóticos F23.9 , insônia G47.2 e Artrose do joelho M17 , fratura do fêmur direito S72 e dor Crônica R52.2.
Vem em uso de diversos medicamentos testados e disponíveis no Brasil, sem melhora clínica com piora progressiva do quadro.

A paciente apresenta hipotonia muscular, rigidez muscular, perda de equilíbrio resultando em muitas quedas, instabilidade ao caminhar, dificuldade com movimentos corporais, inclusive com fratura de fêmur sem quedas, dores lombares intensas e incapacitantes e com possível agravamento por uma maior sensibilidade aos fármacos neurolépticas com um aumento na progressão da doença. E ainda tem apresentado surtos psicóticos e muita ansiedade

A paciente já fez uso de todas as medicações disponíveis como: memantina, quetiapina, clonazepam, Tramadol, zolpidem, melatonina, dentre outros.

Seguido dos seguintes efeitos colaterais: Alteração do humor com picos e alternada, ora sonolência excessiva, ora insônia consecutivas, boca seca, dores musculares, náuseas, perda de peso, falta de ar, alterações gastrointestinais, anorexia, agitação, dor de cabeça, fadiga, palidez, tontura, arritmia, distúrbios visuais, falta de equilíbrio, fala arrastada, problema de memória, irritabilidade entre outros.

Tendo em vista que foi utilizado todo o arsenal medicamentoso disponível no Brasil, vejo no canabidiol a última possibilidade terapêutica para melhora do quadro geral do paciente e de sua qualidade de vida.

Se a paciente não iniciar o tratamento URGENTE poderá gerar dano irreversível para sua saúde geral e até mesmo RISCO DE MORTE pela gravidade do caso.

Em função do quadro descrito e a não resposta das medicações habituais disponibilizadas no país, indico URGENTE, de forma REGULAR e CONTÍNUA, o uso de 1Pure Cannabidiol CBD isolado 6000mg/200mg-ml, na dosagem de 3,5 ml de 12 em 12 horas. (Uso contínuo Prolongado), indicação deste se dá pela refratariedade e complexidade do caso e pelo controle farmacológico da marca e elevado grau de pureza. Não autorizo a troca por conta dos riscos de efeito colateral e não estabilização do quadro de qualquer outra marca por não haver o mesmo controle farmacológico e índice de pureza.

**Referências bibliográficas:**


1. Hoch E, Niemann D, Keller R, Schneider M, Friemel C, Preuss U,Hasan A, Pogarell O. How effective and save is medical cannabis as aa treatment of mental disorders? A systematic review. European Archives of Psichiatry and Clinical Neuroscience. https://doi.org/10.1007/s00406-019-00984-4 2018
2. Krishman S, Cairns R, Howard R. Cannabinoids for the treatment of dementia (Review) .Copyright 2009 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley e Sons, Ltd.
3. Mücke M, Phillips T,Radbruch L, Petzke
4. Passmore M. The cannabinoid receptor agonist nabilone for the treatment of dementia-related agitation. Internation Journal of geriatric psiquiatry, 2008 : 23: 116-117


Atenciosamente,

Dra. Anelise Brack Gestaro
CREMERS 18784

Dra. Anelise Brack Gestaro
Médica
CREMERS 018784

O segundo requisito, consistente na insuficiência econômica de arcar com os custos do tratamento, vem amparado no valor da medicação (evento 27, OUT22), nos comprovantes de renda (evento 27, CHEQ2;evento 27, COMP3), na declaração de hipossuficiência (evento 1, DECLPOBRE4).

Ademais, também preenchido o último requisito, qual seja, registro na ANVISA, no qual, foi autorizado pela agência (evento 1, OUT5).

Diante das alegações da parte autora, corroboradas pela documentação juntada aos autos, restou evidente a sua necessidade em receber o tratamento pleiteado, pois indispensável à manutenção de sua saúde.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos deduzidos por GERTA RUDOLF BRACK contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para confirmar a tutela de urgência e determinar o fornecimento do medicamento **1Pure Cannabidiol CBD isolado,** com a periodicidade e dosagem determinadas pelo(a) médico(a) assistente, e por tempo indeterminado.

A prescrição médica deverá ser atualizada de seis em seis meses, junto ao ponto de distribuição de medicamentos da Secretaria Estadual da Saúde do RS – Farmácia de Medicamentos do Estado ou outro local - pois apesar da indicação de uso contínuo, há necessidade de acompanhamento do tratamento para verificação do uso efetivo e do resultado apresentado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao(à) procurador(a) da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Defiro o benefício da justiça gratuita à parte autora.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Caso interposta apelação e havendo pedido de bloqueio de valores, considerando a necessidade de remessa dos autos à segunda instância, deverá a parte autora distribuir cumprimento provisório de sentença em autos apartados.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, **dê-se vista à parte autora** e procedam-se aos **atos ordinatórios necessários** à cobrança das eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais diligências.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados e vinculando o número do processo de conhecimento.

Por fim, baixe-se

---

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 1/11/2024, às 8:50:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10071079850v11** e o código CRC **3d329aee**.

---

**1**. 1. OBARA, Hilbert Maximiliano Akihito. Reversibilidade das tutelas de urgência: a ponta do iceberg. 1 ed., Curitiba: Appris, 2021, p. 253-304) ↩